



Руководство

ШАБЛОН РАЗБОРА КЛИЕНТСКОГО КЕЙСА

ОТ ЖАЛОБЫ КЛИЕНТА — К ОБОСНОВАННОМУ ПЛАНУ РАБОТЫ

Рабочий шаблон для специалистов по движению, тренеров, специалистов ЛФК, инструкторов пилатеса и йоги и других специалистов, работающих с физической нагрузкой.



НЕ НАЧИНАЙТЕ РАЗБОР КЕЙСА С ВОПРОСА «КАКОЕ УПРАЖНЕНИЕ ДАТЬ?»

Работа с клиентским случаем начинается не с подбора упражнения.

Сначала специалисту важно последовательно разобраться:



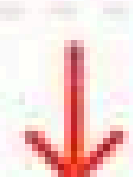
Что беспокоит клиента?



Что ещё нужно уточнить?



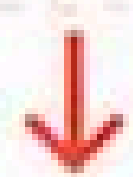
Что необходимо оценить?



Нужна ли консультация врача?



Можно ли брать клиента в работу?



Какую стратегию выбрать?



Как контролировать динамику?



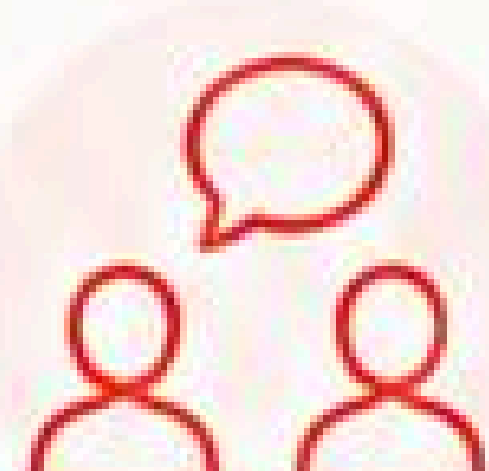
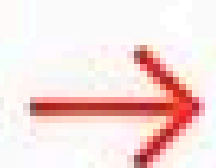
Именно в такой логике работа строится от **жалобы и оценки** к **дальнейшему решению**, а не наоборот. В профессиональной системе отдельно учитываются **скрининг, визуальная оценка, границы компетенции, адаптация нагрузки** и дальнейшее **сопровождение** клиента.



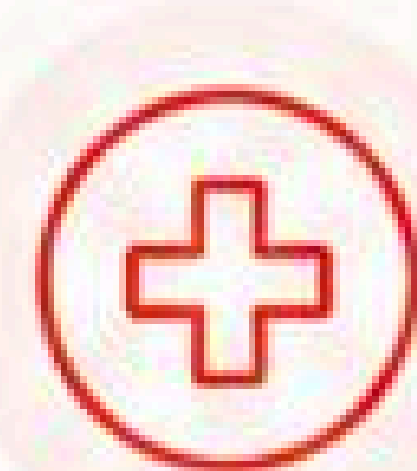
Общее
анкетирование



Дополнительный
опросник
по тазовому дну —
при наличии
соответствующих
сигналов



Диагностическая
встреча



Врач —
при
необходимости



Решение
по дальнейшей
работе

ВАЖНО

ЭТОТ ШАБЛОН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ИЛИ ВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА

Сам по себе шаблон не даёт специалисту достаточной подготовки для работы с дисфункциями тазового дна.

Чтобы применять такую логику в реальной практике, необходимы:

1. Понимание анатомии и биомеханики

Важно понимать взаимосвязь тазового дна с дыханием, внутрибрюшным давлением, мышцами живота, осанкой, тазом и движением.

2. Полноценный сбор анамнеза

Для работы используются не отдельные вопросы из шаблона, а полноценные анкеты и специализированные опросники.

3. Навыки визуальной и функциональной оценки

Специалист должен понимать, что именно он оценивает и как интерпретировать полученную информацию.

4. Понимание границ своей компетенции

Необходимо уметь определить, когда работа через движение допустима, когда требуется совместное ведение, а когда клиенту сначала необходим врач.

5. Практическая подготовка

Алгоритм требует практической отработки на клиентских случаях и навыка принятия решений.

В программе подготовки отдельно предусмотрены расширенные опросники, визуальная диагностика, оценка дыхания и осанки, разделение клиентских сегментов и правила направления к врачу.



Шаблон помогает структурировать уже собранную информацию, но не заменяет обучение, полноценную диагностику и практическую подготовку специалиста.

Специалист по движению не ставит медицинский диагноз и не заменяет врача.

ШАГ 1. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ КЕЙС?

Блок 1. Основная информация

Возраст клиента:

Основной формат физической активности:

Беременности / роды / послеродовой период:

Операции:

Есть ли медицинские ограничения или рекомендации:

Наблюдается ли клиент у профильного врача:

Блок 2. Основная жалоба

Запишите жалобу словами самого клиента

С чем клиент пришёл:

Не нужно сразу переводить жалобу в диагноз или профессиональное заключение.

Блок 3. Контекст жалобы

Когда появилась:

При каких обстоятельствах возникает:

Какая нагрузка провоцирует:

Что происходит после нагрузки:

Что уменьшает проявления:

Что усиливает проявления:

ШАГ 2. НЕ ОГРАНИЧИВАЙТЕСЬ ОДНОЙ ЖАЛОБОЙ

Клиент не всегда связывает свои ощущения с состоянием тазового дна. Если в ходе общения появляются дополнительные сигналы, требуется более глубокий сбор информации и, при необходимости, специализированный опросник.

Отметьте то, что действительно присутствует у клиента:

- ☐ подтекание при физической нагрузке;
- ☐ тяжесть или давление внизу живота;
- ☐ выпирающий живот;
- ☐ диастаз или подозрение на него;
- ☐ боли в пояснице или области таза;
- ☐ изменения после родов;
- ☐ дискомфорт при физической нагрузке;
- ☐ сложности с возвращением к нагрузке;
- ☐ другие жалобы:

Подобные признаки в рабочем алгоритме являются основанием для дополнительного анкетирования по тазовому дну.

Как состояние связано с нагрузкой?

- ☐ не меняется;
- ☐ уменьшается;
- ☐ симптом появляется во время упражнения;
- ☐ усиливается во время упражнения;
- ☐ появляется после тренировки;
- ☐ усиливается при увеличении веса / объёма / интенсивности.

Какие движения или упражнения вызывают вопросы:

ШАГ 3. ЧТО ВЫ УВИДЕЛИ ПРИ ОЦЕНКЕ КЛИЕНТА?

При наличии соответствующих сигналов проводится отдельная диагностическая встреча.

В рабочую оценку входят анализ жалоб, визуальная диагностика, оценка осанки, дыхания и определение дальнейшей тактики.

Жалобы и анамнез

Визуальная оценка

Особенности осанки

Особенности дыхания

Работа живота и корпуса

Что происходит в движении

Реакция на физическую нагрузку

ШАГ 4. СОБЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЮ В ЕДИНУЮ КАРТИНУ



Рабочая гипотеза ≠ медицинский диагноз

Она нужна, чтобы определить, какие факторы необходимо учитывать при построении дальнейшей работы и что ещё требуется уточнить.

1. Основная жалоба клиента



2. Какие дополнительные сигналы обнаружены?



3. Какие элементы требуют внимания?

- ☐ дыхание;
- ☐ внутрибрюшное давление;
- ☐ мышцы живота / корпус;
- ☐ осанка;
- ☐ таз;
- ☐ тазобедренные суставы;
- ☐ тазовое дно;
- ☐ реакция на физическую нагрузку.

4. Что ещё необходимо уточнить или оценить?



5. Рабочая гипотеза

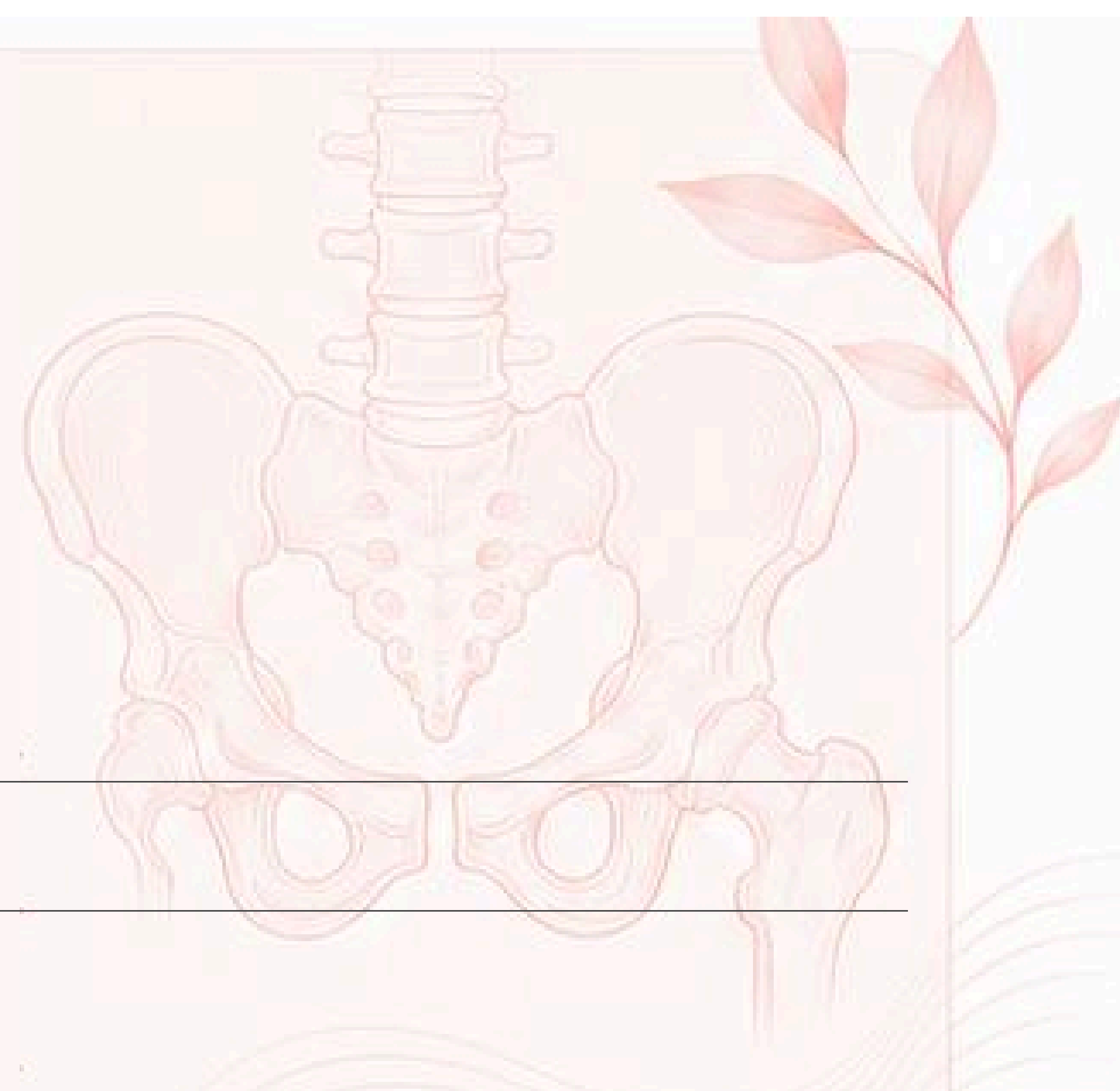
В исходной системе ключевой навык формулируется именно как способность провести скрининг, увидеть риски, выстроить гипотезу дальнейшей работы, определить границы компетенции и маршрутизировать клиента.

ШАГ 5. ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?

БЕРЁМ КЛИЕНТА В РАБОТУ

☐ выбран этот вариант

На основании чего принято решение:



РАБОТАЕМ СОВМЕСТНО С ВРАЧОМ

☐ выбран этот вариант

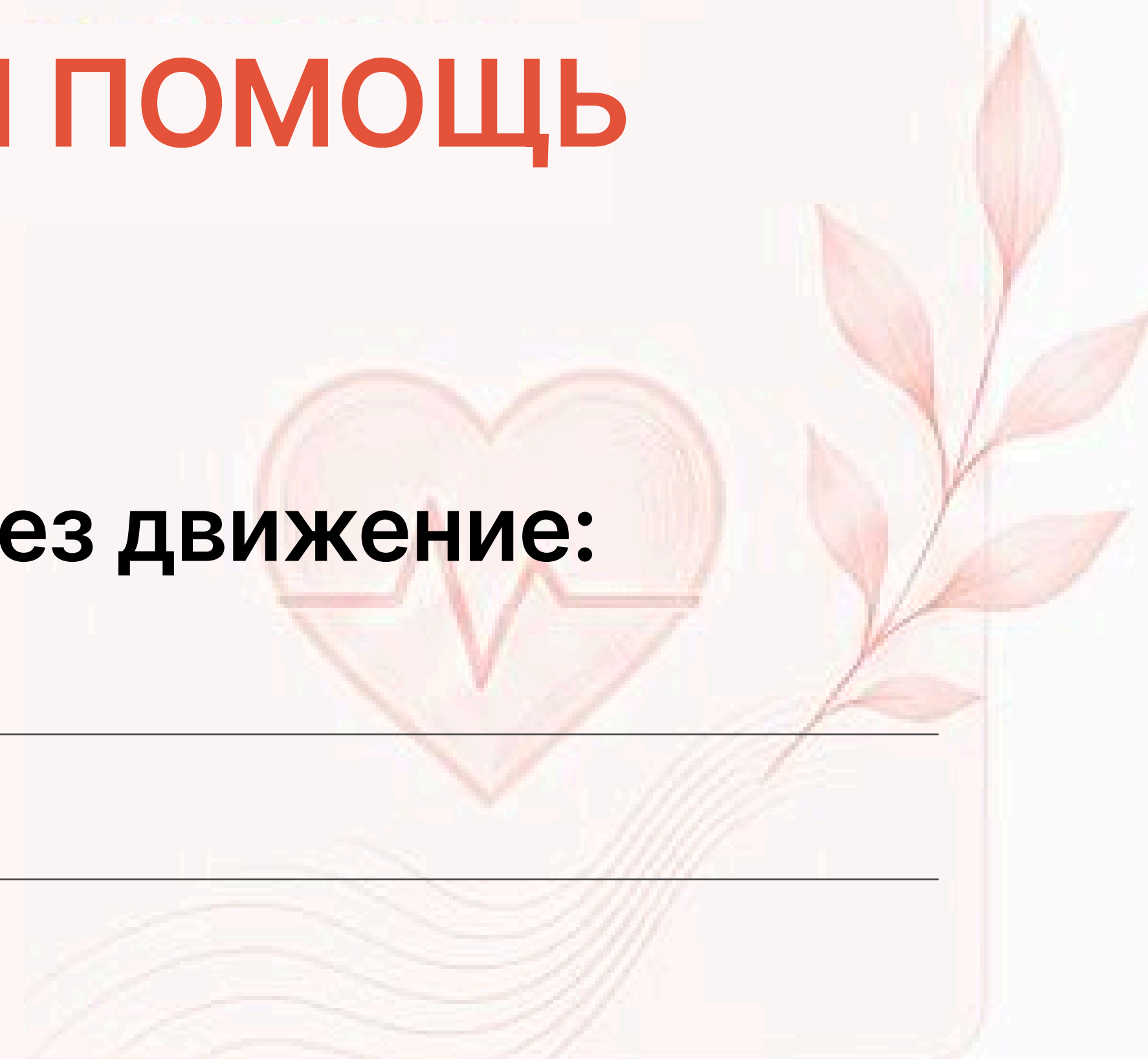
Какие рекомендации или ограничения необходимо учитывать:



СНАЧАЛА НЕОБХОДИМА МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

☐ выбран этот вариант

Что необходимо сделать до возвращения к работе через движение:



В алгоритме прямо предусмотрены три маршрута: взять клиента в работу, работать совместно с врачом либо рекомендовать сначала пройти необходимое лечение и вернуться к восстановлению позже.



Есть ли что-то, что выходит за границы моей компетенции?

☐ нет;

☐ да;

☐ не уверен — требуется консультация профильного специалиста.



Хороший специалист — **не тот,**
кто берёт в работу каждого клиента.



ШАГ 6. СФОРМИРУЙТЕ МАРШРУТ, А НЕ НАБОР УПРАЖНЕНИЙ

Цель клиента

Основные задачи работы

- 1.

- 2.

- 3.

Какие факторы необходимо учитывать?

Какую текущую нагрузку можно оставить?

Что требует адаптации?

Что пока требует дополнительной оценки?

Какой следующий этап прогрессии?



При выборе упражнения специалисту
важно понимать:

- зачем оно необходимо;
- на какую структуру оно воздействует;
- в какой последовательности его использовать;
- как клиент реагирует на нагрузку;
- когда программу необходимо изменить.

ШАГ 7. КАК ПОНЯТЬ, РАБОТАЕТ ЛИ ВЫБРАННАЯ СТРАТЕГИЯ?

1. ОЩУЩЕНИЯ КЛИЕНТА

Что изменилось:



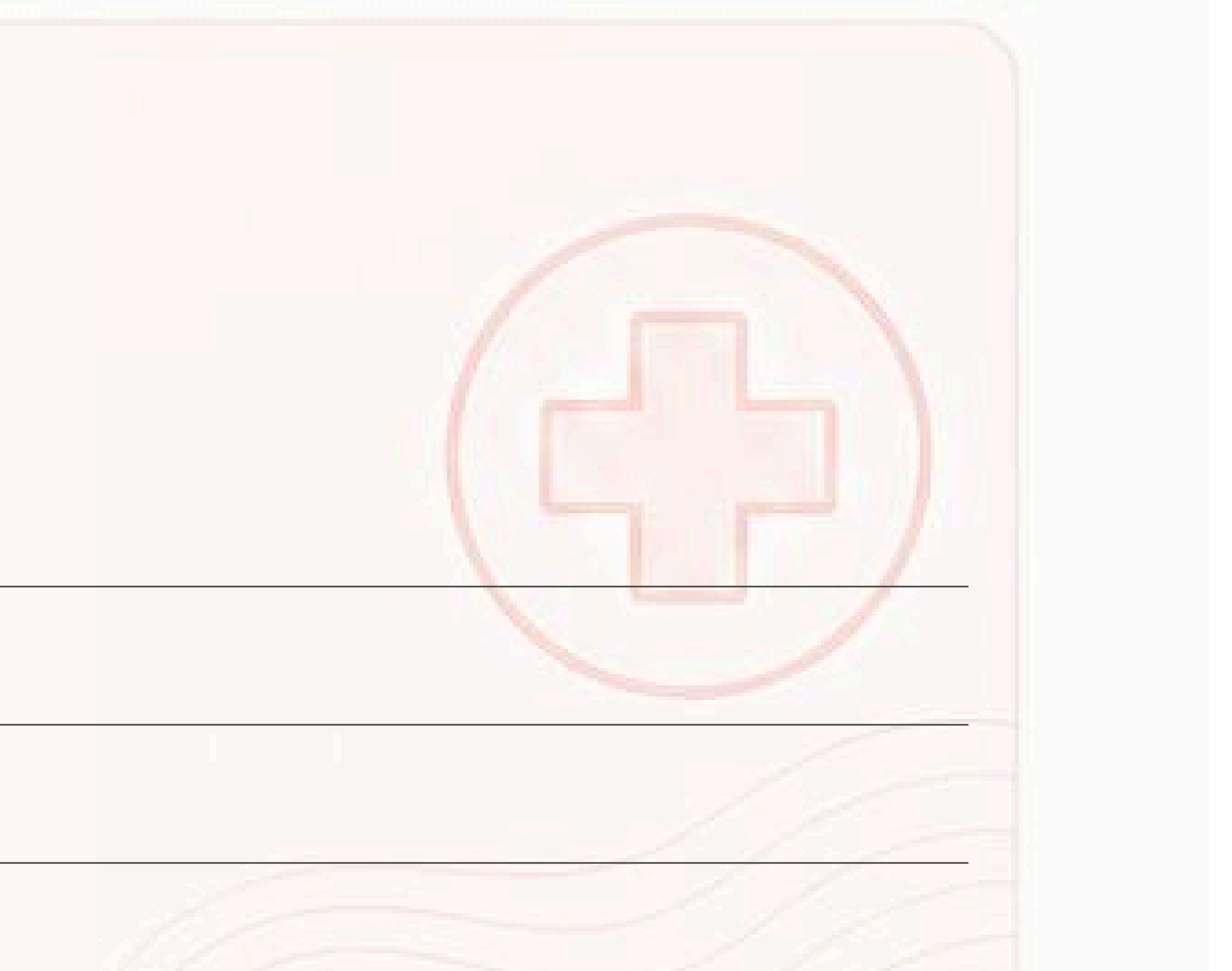
2. ВИЗУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА

Что изменилось при повторной оценке:



3. МЕДИЦИНСКАЯ ДИНАМИКА

Заполняется, если клиент наблюдается у врача:



Именно эти три группы — ощущения клиентки, визуальные изменения и медицинская динамика при наблюдении врача — используются как критерии контроля результата.

Что делаем дальше?

- ☐ продолжаем выбранную стратегию;
- ☐ корректируем отдельные параметры программы;
- ☐ проводим повторную оценку;
- ☐ требуется дополнительная консультация профильного врача.

Что необходимо изменить:

ШПАРГАЛКА РАЗБОРА КЛИЕНТСКОГО КЕЙСА

ЖАЛОБА КЛИЕНТА



АНАМНЕЗ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ



СКРИНИНГ



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА



РАБОЧАЯ ГИПОТЕЗА



ГРАНИЦЫ КОМПЕТЕНЦИИ



РЕШЕНИЕ ПО ВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА



ПЛАН РАБОТЫ



КОНТРОЛЬ ДИНАМИКИ

**Сначала оценка и решение.
Затем — упражнения.**



Понимаю тело → вижу взаимосвязи → провожу оценку
→ подбираю решение → контролирую результат.